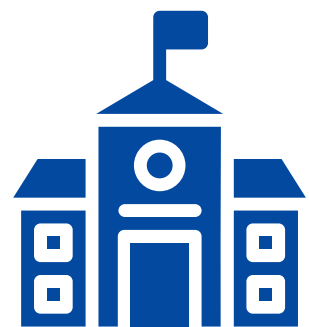




Care manager / อปท.

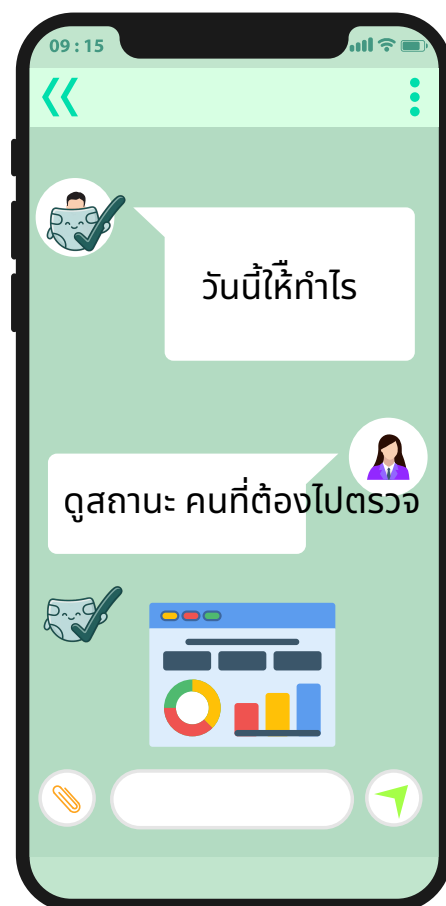
ติดตามง่าย



ศูนย์อนามัยและ รพ.สต.

(อสม. และ
Care giver)

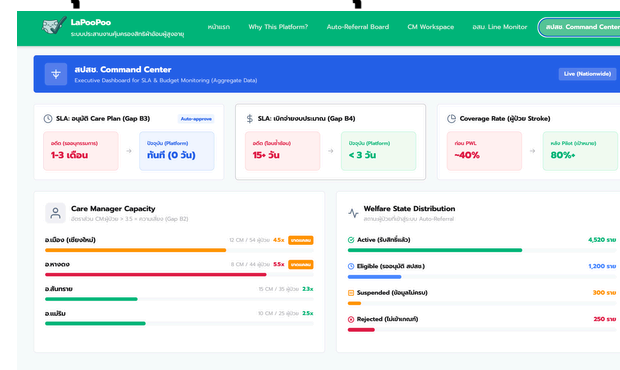
ประเมินง่าย



สปสช.

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

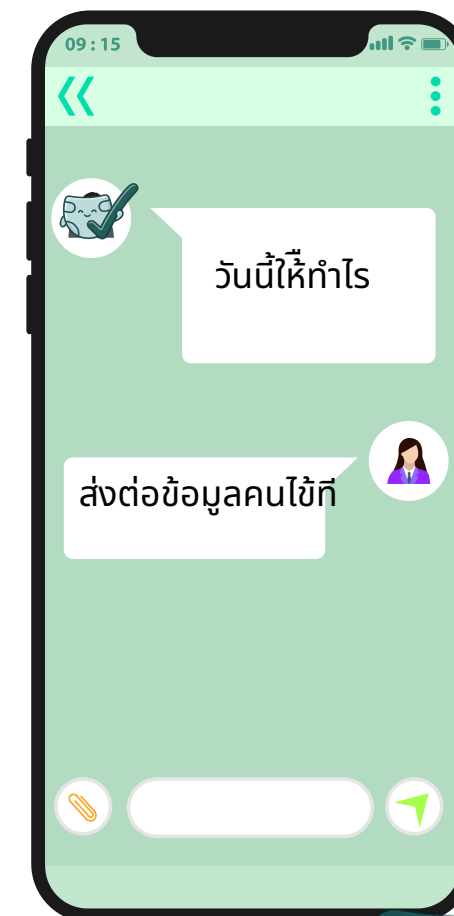
กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.)



command center

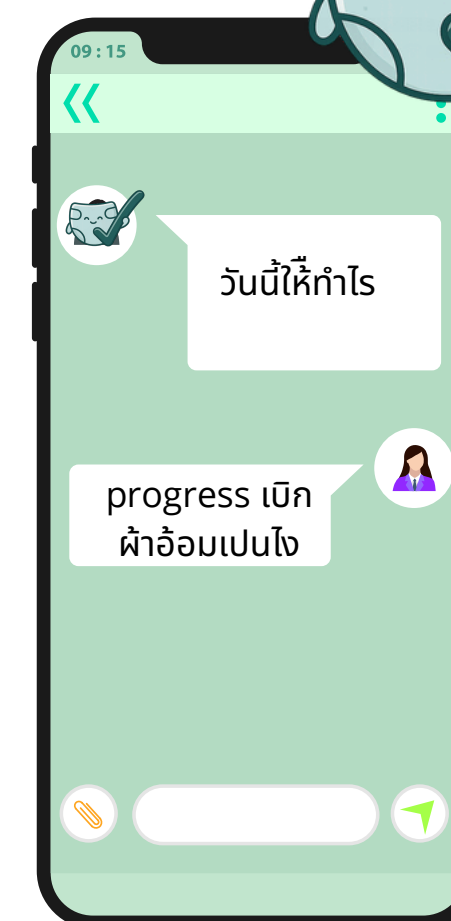
LaPooPoo Agent

ระบบ auto “ประสานงาน” คู่ครองสิทธิผ้าอ้อมผู้สูงอายุ
LTC Diaper Auto-Referral Agent



พยาบาลที่โรงพยาบาล/ หน่วยเวชสิทธิ์

ส่งต่อ
auto referral



พยาบาลที่โรงพยาบาล/ หน่วยเวชสิทธิ์

รู้ progress

**สิทธิผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองซับ ดูแลและรับผิดชอบหลักโดย
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกับกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) ซึ่งครอบคลุมคนไทยทุกสิทธิการรักษา
พยาบาล (รวมถึงสิทธิบัตรทอง ประกันสังคม และสวัสดิการข้าราชการ)
[1, 2, 3]**

**คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับผ้าอ้อม: [1]
เป็นผู้ป่วยติดเตียง ที่มีคะแนนประเมินความสามารถในการประกอบ
กิจวัตรประจำวัน (ADL) ไม่เกิน 6 คะแนน
หรือเป็นผู้ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะ/อุจจาระไม่ได้ ตามการประเมินของเจ้า
หน้าที่สาธารณสุข [1]**

วิธีการขอรับสิทธิ:

**สามารถไปลงทะเบียนและแจ้งความประสงค์ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ [1]
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรือศูนย์บริการสาธารณสุข
ใกล้บ้าน
องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หรือ สำนักงานเทศบาล ในเขตพื้นที่พัก
อาศัยอยู่จริง (ไม่จำเป็นต้องตรงกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน) [1]
เจ้าหน้าที่จะทำการประเมินและจัดหาผ้าอ้อม (ไม่เกิน 3 ชิ้นต่อคนต่อวัน)
ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) ต่อไป
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330**

อยากสื่อให้รู้ว่า step แต่ละอันเป็นยังไง workflow User journey ติดต่อ

ใคร ใครดูแล สามารถรวมหน้า 17-19

นี่คือขั้นตอน (Flow) การทำงานอย่างละเอียดในการขอรับสิทธิผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และกองทุนท้องถิ่น (กปท.) ครับ

1. ขั้นตอนการเตรียมการและยื่นเรื่อง (Initiation)

ผู้ยื่นเรื่อง: ผู้ป่วยเอง, ญาติ, ผู้ดูแล, หรือผู้นำชุมชน/อสม.

สถานที่ยื่นเรื่อง: รพ.สต., ศูนย์บริการสาธารณสุข (สาธารณสุขกรุงเทพฯ), อบต. หรือ เทศบาล ในพื้นที่ที่ผู้ป่วยอาศัยอยู่จริง

เอกสารที่ต้องใช้:

บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ป่วย

บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้งเรื่อง/ผู้ดูแล

ทะเบียนบ้าน (ถ้ามี)

ประวัติการรักษาหรือใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)

2. ขั้นตอนการลงพื้นที่และประเมินอาการ (Screening & Assessment)

การนัดหมาย: เจ้าหน้าที่สาธารณสุข (พยาบาลวิชาชีพ หรือ นักกายภาพบำบัด) ร่วมกับ อสม. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วย

การประเมิน: เจ้าหน้าที่ใช้แบบประเมินทางการแพทย์เพื่อจัดกลุ่มผู้ป่วยเป็น 2 กลุ่มหลัก:

กลุ่มที่ 1 ผู้ป่วยติดเตียง: ประเมินคะแนนกิจวัตรประจำวัน (ADL) ต้องได้ ไม่เกิน 6 คะแนน

กลุ่มที่ 2 ผู้ที่มีปัญหาเคลื่อนไหว: มีภาวะกลืนลำบากหรืออุจจาระไม่ได้ (ไม่จำกัดคะแนน ADL แต่ต้องมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์)

3. ขั้นตอนการจัดทำแผนและอนุมัติงบประมาณ (Care Plan & Approval)

เขียนแผนการดูแล (Care Plan): ผู้จัดการระบบดูแลระยะยาว (Care Manager) จัดทำแผนระบุจำนวนผ้าอ้อมที่จำเป็น (สูงสุดไม่เกิน 3 ชิ้น/คน/วัน)

เสนอโครงการ: รพ.สต. หรือชุมชน เสนอโครงการขอรับงบประมาณไปยัง "กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.)" ของ อบต. หรือเทศบาลนั้นๆ

การอนุมัติ: คณะกรรมการกองทุน กปท. ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบประมาณตามแผน Care Plan ที่เสนอมา

4. ขั้นตอนการจัดซื้อและการส่งมอบ (Procurement & Delivery)

จัดซื้อจัดจ้าง: อบต./เทศบาล หรือ รพ.สต. ดำเนินการจัดซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่หรือแผ่นรองขับตามมาตรฐานทางการแพทย์

ส่งมอบถึงบ้าน: อสม. ผู้ดูแล หรือเจ้าหน้าที่ นำผ้าอ้อมไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ป่วยถึงที่บ้าน (โดยส่วนใหญ่จะแจกจ่ายเป็นรอบ เช่น รายเดือน หรือราย 3 เดือน)

5. ขั้นตอนการติดตามและประเมินซ้ำ (Monitoring & Follow-up)

ติดตามผล: เจ้าหน้าที่และ อสม. จะแวะเวียนมาตรวจเยี่ยมอาการและตรวจสอบการใช้ผ้าอ้อมเป็นระยะ

ประเมินซ้ำ: มีการประเมินสิทธิใหม่เป็นรายปี หรือเมื่อผู้ป่วยมีการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพ (เช่น อาการดีขึ้นจนเดินได้เอง หรือย้ายที่อยู่) เพื่อปรับปรุงข้อมูลในระบบ

หากต้องการตรวจสอบว่า อบต. หรือ รพ.สต. ในพื้นที่ของคุณเริ่มเปิดรับงบประมาณรอบปัจจุบันแล้วหรือยัง สามารถโทรเช็คโดยตรงได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330 (โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง) ครับ

Stakeholders อธิบายว่าใครทำอะไร ได้อะไร ทำแทน 14 ทำเป็น journey โดยทำให้เข้าใจโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีคนเล่า สามารถรวมนำ 17-19

โครงสร้างการทำงานและอุปสรรคของการกระจายผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฟรีภายใต้ระบบ สปสช. มีรายละเอียดกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง และปัญหาหน้างานที่เกิดขึ้นจริงดังนี้ครับ [1, 2]

 1. Stakeholders (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด)
การบริหารจัดการโครงการนี้ขับเคลื่อนด้วย 3 กลุ่มหลัก คือ ผู้ให้งบ ผู้ตัดสินใจ และผู้ลงมือทำ

-  กลุ่มที่ 1: ผู้ให้งบประมาณ (Funders)
- สปสช. (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ): เป็นผู้จัดสรรงบประมาณก้อนใหญ่จากส่วนกลาง ลงไปสมทบใน "กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่" (กปท.) [1, 2]
 - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. / เทศบาล): ควักเงินจากงบประมาณท้องถิ่นตัวเองส่วนหนึ่งมาร่วมสมทบเข้ากองทุน กปท. เพื่อให้มีเงินหมุนเวียนพยาบาลคนในพื้นที่ [1, 2]

-  กลุ่มที่ 2: ผู้ตัดสินใจและอนุมัติ (Decision Makers)
- คณะกรรมการกองทุน กปท. (มีนายก อบต. หรือนายกเทศมนตรี เป็นประธาน): เป็นกลุ่มที่มีอำนาจ อนุมัติหรือไม่อนุมัติเบิกเงินที่จะนำไปจัดซื้อผ้าอ้อม โดยพิจารณาตามแผนที่โรงพยาบาลหรือชุมชนเสนอขึ้นมา [1]
 - Care Manager (ผู้จัดการระบบดูแลและยาว) / พยาบาลวิชาชีพ: เป็นผู้ตัดสินใจในเชิงการแพทย์ ว่าผู้ป่วยคนนี้ ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิหรือไม่ และควรได้จำนวนเท่าใด (ไม่เกิน 3 ชิ้น/วัน) [1, 2]

-  กลุ่มที่ 3: ผู้ลงมือทำและปฏิบัติงาน (Implementers)
- sw.สต. / ศูนย์บริการสาธารณสุข / ชุมชน: เป็นผู้เขียนตัวโครงการและจัดทำแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) เพื่อยื่นขอเงินจาก กปท. [1, 2]
 - กองสาธารณสุขของ อบต. หรือเทศบาล: ทำหน้าที่ดำเนินเรื่องงานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้างผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้ได้ตามมาตรฐานและราคาที่กำหนด (ไม่เกินชิ้นละ 9.50 บาท) [1]
 - อสม. (อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน) / CG (Caregiver): เป็นมดงานหลักในการลงพื้นที่ คัดกรองผู้ป่วย แยกแยะเพศไปแจกจ่ายถึงเตียงนอน และคอยติดตามอาการ [1]
 - ผู้ป่วยและญาติ: เป็นผู้ส่งข้อมูล ยื่นเอกสารสิทธิ และคอยรับมอบของ [1, 2]

 2. ปัญหาและคอขวดอยู่ตรงไหน? (Pain Points)
แม้ว่านโยบายนี้จะส่งผลดีอย่างมาก แต่ในทางปฏิบัติจริงกลับพบปัญหาในหลายมิติ ดังนี้: [1, 2]

-  ปัญหาหน้างานและการสื่อสาร (Operation & Communication)
- ข้อมูลไม่ทั่วถึง (sw.สต. หรือ อบต. ปิดปฏิกิเสธ): ประชาชนหลายคนโทรไป สปสช. 1330 แล้วเจ้าหน้าที่บอกว่ามีสิทธิ แต่พอเดินไปติดต่อ sw.สต. หรือ อบต. ใกล้บ้านกลับได้รับคำตอบว่า "ไม่รู้เรื่อง" หรือ "ไม่มีงบ" เนื่องจากนโยบายจากส่วนกลางยังส่งไปไม่ถึงระดับปฏิบัติการในท้องถิ่นนั้นๆ
 - งบประมาณ กปท. บางตำบลไม่พอ: ตำบลที่มีผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงหนาแน่น จะประสบปัญหางบประมาณของกองทุน กปท. ประจำปีหมดก่อน ทำให้ไม่สามารถแจกผ้าอ้อมได้อย่างต่อเนื่องทุกเดือน
 - ภาระงานล้นมือของมดงาน (อสม. / CM): การทำคัดกรอง เขียนแผน Care Plan และการขนย้ายผ้าอ้อมก้อนใหญ่ไปส่งตามบ้าน เป็นงานที่ต้องใช้แรงและเวลาสูงมาก ขณะที่บุคลากรสาธารณสุขในระดับพื้นที่มีจำกัด [1, 2, 3, 4, 5]

Bottlenecks + Entry point **รู้ว่าจะแก้ที่ไหน เช่น highlight**

สามารถรวมหน้า 17-19

หากคุณต้องการนำ Line AI Agent เข้ามาช่วยประสานงานเพื่อทำ Auto Refer (ระบบส่งต่อและจับคู่สิทธิอัตโนมัติ) คุณจะสามารแก้ Pain Point ใหญ่ของระบบราชการเดิมได้อย่างมหาศาล โดยจุดที่ควส่ง AI Agent เข้าไปตัดวงจรคอขวด (Bottlenecks) มี 5 จุดสำคัญตาม Swimlane Diagram ดังนี้ครับ:

🚨 5 จุดที่ Line AI Agent ควรเข้าไปแก้เพื่อทำ Auto Refer

1. ตัดคอขวดการยื่นเอกสาร: "Auto-Screening & Document Parsing" (เลา 1 ➡ เลา 2)

- ปัญหาเดิม: ญาติเดินทางไป sw.สต. เอง หรือ อสม. ต้องเดินจดข้อมูลลงกระดาษ ซึ่งเอกสารมักไม่ครบ
- สิ่งที่ AI Agent ต้องทำ:
- - ให้อาาติหรือ อสม. ถ่ายรูปบัตรประชาชนผู้ป่วยส่งเข้าไป Line
 - AI ทำการดึงข้อมูล (OCR) และเช็กสิทธิบัตรทอง/ประกันสังคมอัตโนมัติผ่าน API ของ สปสช.
 - AI ส่งแบบประเมิน ADL เป็นข้อง่ายๆ ให้ อสม. กดเลือกใน Line จากนั้นระบบจะคำนวณคะแนนให้อัตโนมัติทันทีเพื่อสรุปว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่

2. ตัดคอขวดงานเอกสารของแพทย์: "Auto Care Plan Generation" (เลา 2)

- ปัญหาเดิม: Care Manager และพยาบาล sw.สต. ไม่มีเวลาเขียนโครงการเล่มหนาๆ เพื่อเสนอขออนุมัติงบ
- สิ่งที่ AI Agent ต้องทำ:
- - เมื่อคัดกรองผ่านเกณฑ์ในข้อ 1 แล้ว ให้ AI นำข้อมูลดิบมา Gen เอกสาร "แผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan)" และ "ร่างโครงการขอรับงบ กปท." ตาม Format ของ สปสช. ให้เสร็จสรวภายใน 1 วินาที
 - พยาบาลแค่กด "ตรวจสอบความถูกต้อง" และกด "อนุมัติส่งต่อ" (Auto Refer) ผ่าน Line หน้าทีของมนุษย์เหลือแค่การตรวจสอบ (Verify) ไม่ต้องพิมพ์เอง

3. แก้ปัญหางบหมดและการติดตาม: "Dynamic Budget & Follow-up Tracker" (เลา 3 ➡ เลา 1)

- ปัญหาเดิม: งบประมาณ อบต. บางแห่งหมด แต่บางแห่งเหลือเฟือ และ อสม. ลืมติดตามผลรายปี
- สิ่งที่ AI Agent ต้องทำ:
- - Auto Refer งบประมาณ: หากงบ กปท. ในพื้นที่นั้นหมด AI สามารถยื่นเรื่องส่งต่อไปยังงบกลางของ สปสช. หรือกองทุนจังหวัดให้อัตโนมัติ เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยขาดสิทธิ
 - Auto Follow-up: เมื่อครบกำหนด 1 ปี AI จะทัก Line หา อสม. หรือญาติ เพื่อให้กดประเมินอาการซ้ำ หากอาการเปลี่ยน (เช่น เดินได้แล้ว หรือเสียชีวิต) AI จะคัดชื่อออกเพื่อคืนงบเข้าส่วนกลางทันที
-

💡 ภาพรวมของระบบหลังมี AI Agent

กระบวนการติดต่อยจะเปลี่ยนจาก "คนเดินหาหน่วยงาน" เป็น "ข้อมูลวิ่งหาหน่วยงานผ่าน AI"

[ญาติ/อสม. ถ่ายรูปส่ง Line] ➡ [AI คัดกรอง + Gen เอกสาร] ➡ [หมอ/อบต. กดอนุมัติผ่าน Line] ➡ [ของส่งถึงบ้าน]

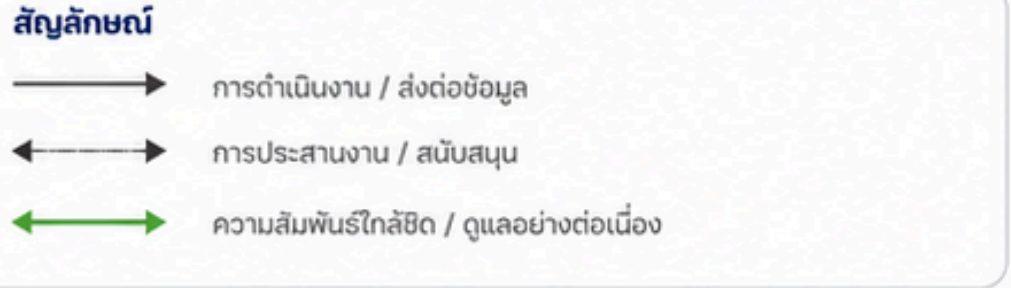
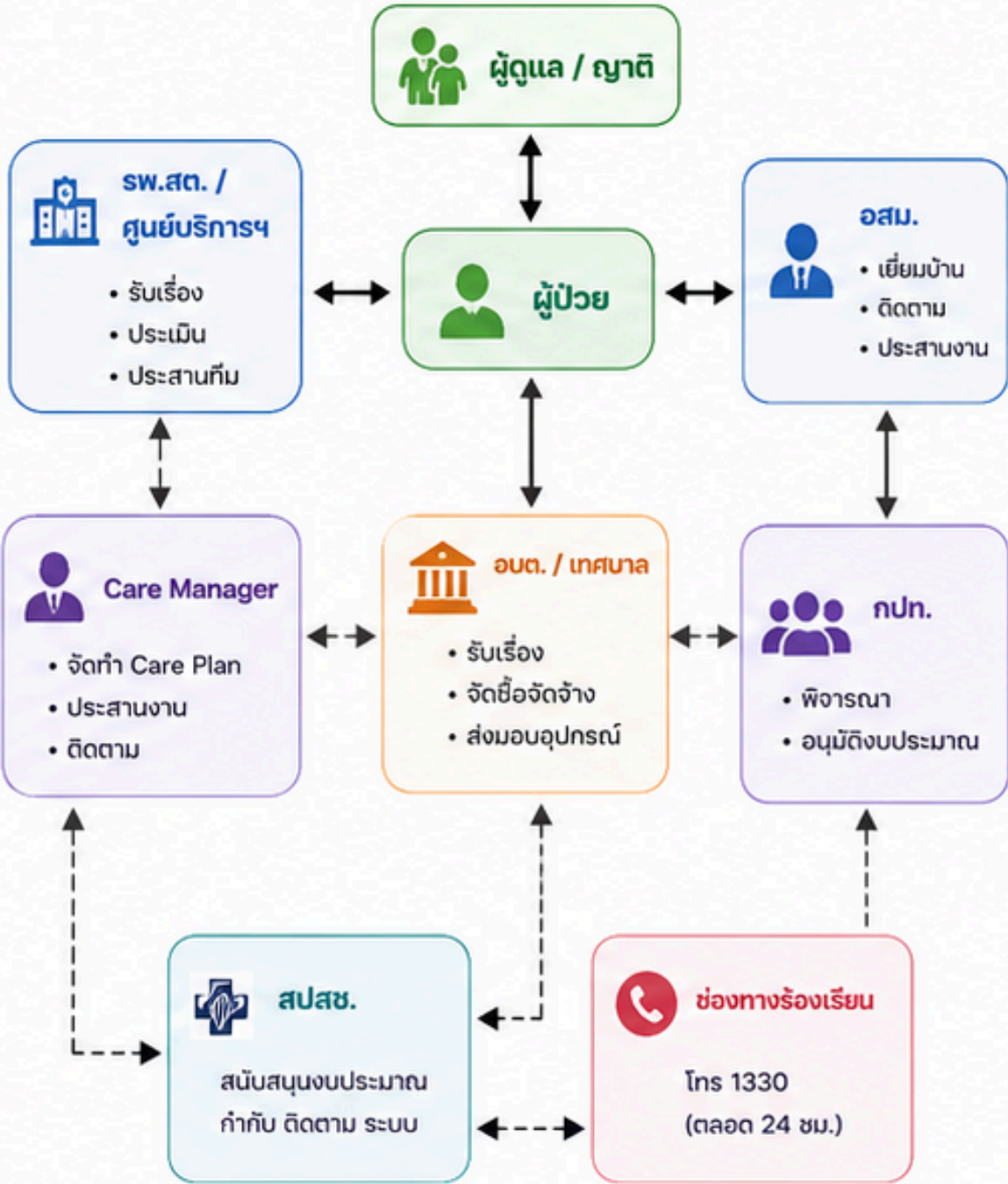
หากคุณกำลังพัฒนาโปรเจกต์นี้อยู่ มีการวางแผนจะเชื่อมต่อกับ API ของ สปสช. โดยตรงเลยไหมครับ? หรืออยากให้ผมช่วยดีไซน์ User Journey ของตัว Line Agent ในมุมมองของ อสม./ญาติ เพิ่มเติมเพื่อให้เห็นภาพการกดใช้งานจริงครับ?

แผนภาพกระบวนการดูแลและสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วย (Flow)

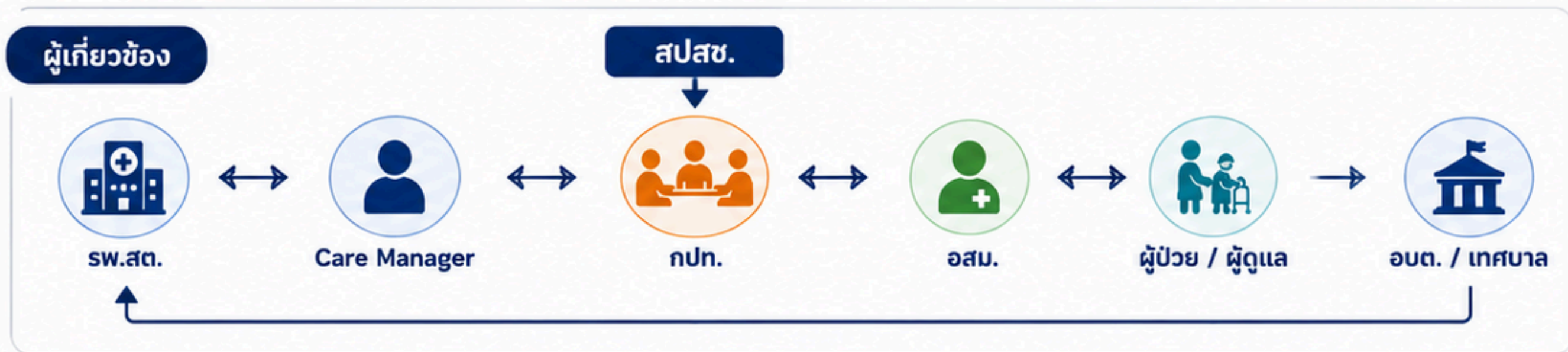
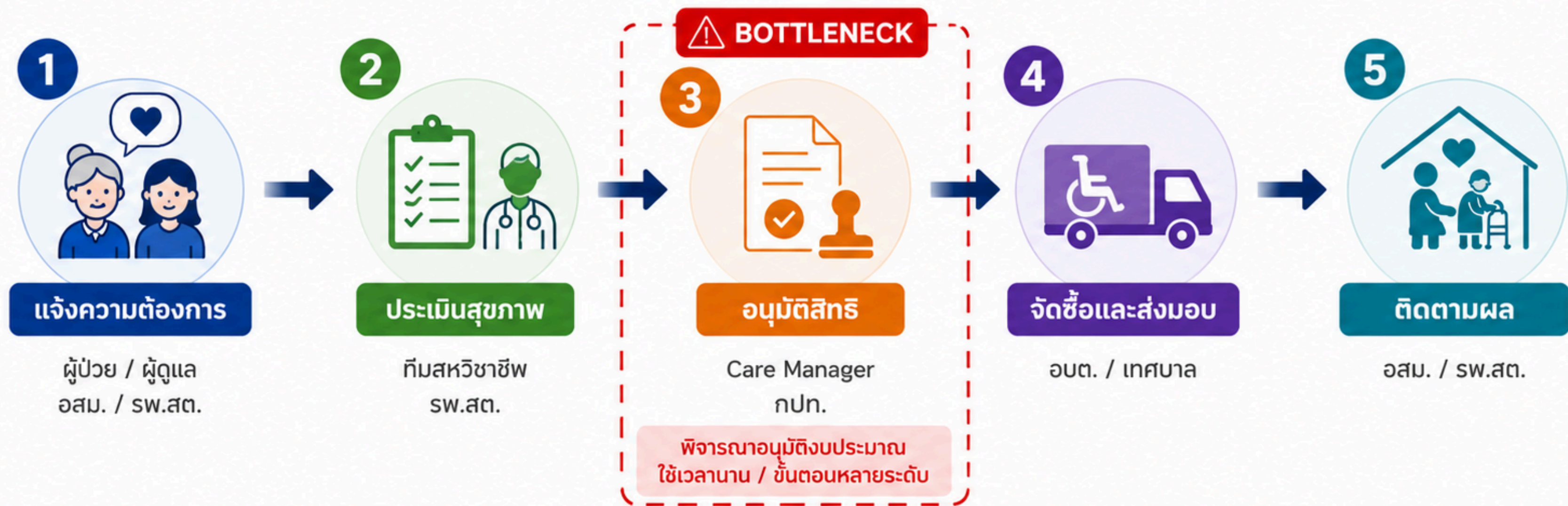
ใครทำอะไร เชื่อมต่อกันอย่างไร



แผนภาพความสัมพันธ์ของผู้เกี่ยวข้อง (Stakeholder Map)



กระบวนการเข้าถึงสิทธิอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วย



ระบบที่ขาดการ trigger action คือเหตุผลที่ผู้สูงอายุไม่ได้รับการดูแลที่ควรได้



Good Model that cannot scale

ปัญหาหลัก

5.3 ต่อ 1

ผู้ดูแลต้องรับผิดชอบผู้สูงอายุสูงสุด 7 รายต่อผู้จัดการดูแล 1 คน ในบางพื้นที่ ทำให้มีความรับผิดชอบที่มากเกินไป

ปีละ 2 ครั้ง

รอบอนุมัติแผนดูแล ผู้ป่วยรายใหม่ไม่สามารถเบิกวัสดุจำเป็นได้ทันท่วงที

48.7%

ของผู้ดูแลเคยเบิกเงินล่าช้าหรือไม่ได้รับเลย ทำให้ออกจากระบบ

Source: ตารางที่ ๑๑-๑๒ ระบบข้อมูลบุคลากรการดูแลระยะยาว กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๖๗

Source: ระบบการดูแลระยะยาวในประเทศไทยช่วงทศวรรษล่าสุด หน้า ๒๕๒ คณะแพทยศาสตร์ sw.รามารับดี

Source: Khongboon et al., 2023



กรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพฯ มีการจัดการด้านทรัพยากรที่ดี ทั้งด้านคนและเงิน

1.ผู้จัดการดูแลหนาแน่น กทม. มีสัดส่วนผู้จัดการดูแลต่อประชากรสูงกว่าต่างจังหวัดหลายเท่า สามารถเยี่ยมบ้านได้จริง

2.ระบบส่งต่อชัดเจน โรงพยาบาลไปศูนย์บริการสาธารณสุขไปสู่ผู้จัดการดูแล ครบวงจร

3.แผนการดูแลครบถ้วน ผู้ป่วยได้รับบริการกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด และสังคมสงเคราะห์ตามสิทธิ์

ระบบทริกเกอร์และส่งต่ออัตโนมัติ ปัญญาประดิษฐ์ร่างแผนดูแลรวมไปทั้งการติดตามเชิงรุก

ทริกเกอร์จากระบบโรงพยาบาล

วินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง ระบบส่งตัวคัดกรองทันที ไม่ต้องรอรอบประชุมอนุกรรมการ

ไลน์เอเจนต์ประเมินความสามารถ

อาสาสมัครถามผ่านไลน์ ปัญญาประดิษฐ์ร่างแผนดูแล ผู้จัดการดูแลอนุมัติโดยไม่ต้องเดินทาง

แดชบอร์ดและแจ้งเตือนอัตโนมัติ

สปสช. และกองทุนท้องถิ่น เห็นคิว คะแนนความสามารถ และงบค่าใช้จ่ายแบบทันที พร้อมแจ้งเตือน

ผู้สูงอายุทุกคนควรได้รับสิทธิการรับผ้าอ้อมเหมือนกันทั่วประเทศ

Core Features

เพื่อขยายผลระบบ Line AI Agent ไปสู่การทำ Auto Refer จากโรงพยาบาล (sw.ใหญ่/sw.ศูนย์) ไปยังชุมชน (sw.สต./อบต.) จุดนี้คือหัวใจสำคัญของการทำ Discharge Planning (วางแผนจำหน่ายผู้ป่วย) เพราะเดิมที่ผู้ป่วยติดเตียงรายใหม่มักหลุดสิทธิผ้าอ้อมในช่วงรอยต่อที่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลกลับไปอยู่บ้าน
นี่คือจุดติดคอขวดและ Flow การทำงานที่ AI Agent ต้องเข้าไปจัดการเพื่อทำ Auto Refer จากโรงพยาบาลครับ

 3 จุดวิกฤตที่ต้องแก้เมื่อทำ Auto Refer จากโรงพยาบาล

1. เปลี่ยนจาก "ญาติเดินเรื่อง" เป็น "ระบบส่งข้อมูลล่วงหน้า" (sw.  ชุมชน)

ปัญหาเดิม: ผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุหรือเส้นเลือดสมองตีบ กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงที่โรงพยาบาล พอหมอให้กลับบ้าน ญาติถึงเพิ่งเริ่มไปติดต่อ sw.สต. ซึ่งต้องใช้เวลาเดินเรื่องอีก 1-2 เดือน ทำให้ช่วงแรกต้องแบกรับค่าผ้าอ้อมเองทั้งหมด

แก้ไขด้วย AI Agent:

Trigger ตั้งแต่อยู่ในตึก: เมื่อแพทย์/พยาบาลเจ้าของไข้บันทึกผลประเมิน ADL ในระบบ HIS (Hospital Information System) ของโรงพยาบาลแล้วได้คะแนน ≤ 6 หรือบันทึกว่ามีภาวะอื่นซับซ้อนถ่ายไม่ได้

Auto-Notification: AI Agent จะดึงข้อมูลสิทธิและที่อยู่จริงของผู้ป่วย แล้วยิงข้อมูล Refer ข้ามระบบไปยัง Line ของ Care Manager (CM) ในพื้นที่ sw.สต. ปลายทางทันที ตั้งแต่ผู้ป่วยยังนอนอยู่โรงพยาบาล เพื่อให้ชุมชนเตรียมงบประมาณและผ้าอ้อมรอไว้ล่วงหน้า

2. เชื่อมโยงระบบ HIS ของโรงพยาบาล กับระบบสารสนเทศของ สปสช. และ กปท.

ปัญหาเดิม: ข้อมูลฝั่งสาธารณสุข (โรงพยาบาล) กับข้อมูลฝั่งท้องถิ่น (อบต./เทศบาล) อยู่คนละท่อและไม่คุยกัน โรงพยาบาลไม่รู้ว่า อบต. ปลายทางมีงบผ้าอ้อมเหลือไหม ส่วน อบต. ก็ไม่รู้ว่าผู้ป่วยรายใหม่กำลังจะกลับมาในพื้นที่

แก้ไขด้วย AI Agent:

AI ทำหน้าที่เป็น Data Bridge Interoperability แปลงรหัสโรค (ICD-10) และผลประเมินจากโรงพยาบาล ให้กลายเป็นเอกสาร Care Plan (แผนการดูแล) ที่พร้อมยื่นอนุมัติในฝั่ง กปท. ได้ทันทีโดยไม่ต้องคีย์ข้อมูลซ้ำ

AI จะทำการตรวจสอบโควตาสต็อกผ้าอ้อมในพื้นที่ปลายทางให้อัตโนมัติ หากพื้นที่นั้นงบเต็ม AI จะทำ Auto-Reroute ไปขออนุมัติจากงบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัดแทน

3. ปิดรอยต่อการส่งมอบของในวันแรกที่กลับบ้าน (Discharge Day Match)

ปัญหาเดิม: วันที่รพพยาบาลหรือญาติเตรียมพากลับบ้าน แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ผ้าอ้อมสิทธิบัตรทองจะไปถึงบ้านพร้อมผู้ป่วยในวันแรก

แก้ไขด้วย AI Agent:

เมื่อโรงพยาบาลกด "Confirm Discharge Date" (กำหนดวันกลับบ้าน) ในระบบ

AI Agent จะสั่งการไปยังระบบขนส่ง/อสม. ในพื้นที่ปลายทาง ล็อกคิวแจกจ่ายผ้าอ้อมงวดแรกไปสแตนด์บายที่บ้านของผู้ป่วยล่วงหน้า 1 วัน หรือจัดเซตผ้าอ้อมฉุกเฉิน (Emergency Pack) ส่งมอบให้ญาติถือกลับไปพร้อมตัวผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเลย

 Flow การทำงานย่อย (Micro-Flow) ของ AI Agent ตอนผู้ป่วยอยู่โรงพยาบาล

[หมอประเมิน ADL ในระบบ sw.]



[AI Agent ตรวจจบ: คะแนน ≤ 6]  [AI ค้นหาพิกัดบ้าน + เช็กสิทธิ สปสช.]

